



强迫症 (OCD)

作者: [Katharine Anne Phillips](#), MD, Weill Cornell Medical College;

[Dan J. Stein](#), MD, PhD, University of Cape Town

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 11月 2025 | 修改的 1月 2026

强迫症的特征是强迫观念、强迫行为或两者兼有。强迫观念是反复出现的、持续的、不想要的、激发焦虑的侵入性念头、画面或冲动。强迫行为（也称为仪式）是患者感到被驱使着反复执行的特定行为或心理行为，以试图减轻或预防由强迫意念引起的焦虑。

- 很多强迫性观念和行为都与对伤害或危险的担忧有关。
- 当患者有强迫观念、强迫行为或两者兼而有之时，医生会诊断该疾病。
- 治疗方法可包括暴露治疗（以预防强迫性仪式）和使用抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或氯丙咪嗪）。

强迫症 (OCD) 在女性中的发病率略高于男性，在总人群中的发病率约为 1% 至 3%。平均来说，OCD 开始于 19 至 20 岁左右。（另见[儿童和青少年的强迫症](#)。）很多 OCD 患者也患有或曾经患有[抽动障碍](#)。

OCD 不同于精神障碍，后者的特征是与现实失去联系，但极少数 OCD 病例缺少洞察力。OCD 也不同于[强迫型人格障碍](#)，虽然这两种疾病的患者可能具有一些共同的特点，比如守秩序、值得信赖或完美主义。

强迫症的症状

强迫症 (OCD) 患者存在强迫观念——反复出现一些想法、画面或冲动，即使患者并不想这样。这些强迫观念可侵入患者的脑海，即使是在患者考虑或做其他事情时。另外，强迫观念通常可导致极大的困苦或焦虑。

常见的强迫观念包括：

- 担心污染（如担心接触门把手会引起疾病）
- 多疑（例如担心家正门没有锁）
- 担心物品没有完全排整齐或放平
- 禁止或禁忌的想法（例如，攻击性或性强迫观念）
- 伤害（伤害自己或他人）

其他观念也可能发生。由于强迫观念不使人愉悦，所以患者经常会试图忽视和/或控制它们。

大多数 OCD 患者同时具有强迫观念和强迫行为。强迫动作（又称强迫性仪式）是患者应对强迫观念的一种方法。例如，患者可能会觉得不得不反复地、有目的地和故意地做一些事情，以试图预防或缓解由强迫观念导致的焦虑。

隐性残疾：强迫症 (OCD)

视频

常见的强迫动作包括：

- 为去除污染而反复洗涤或清洁
- 检查多次以缓和疑虑（例如检查以确定门锁了）
- 计数（例如重复一个动作一定次数）
- 整理排序（例如将餐具或工作区物品排列成特定的顺序）

大多数强迫行为可被发现，如反复洗手或反复检查门是否锁好等。其他的仪式，如心里重复计数，是无法被发现的。

强迫行为可能需要刻板地遵守严格的规则来完成。强迫行为可能与强迫观念存在逻辑联系，也可能没有。当强迫动作与强迫观念存在逻辑联系时（例如，为了不使自己脏而洗澡或者检查炉灶以防止火灾），它们相比正常行为就明显过度。例如，患者可能每天洗澡数小时，或者总在离家前检查炉灶 30 次。要诊断为 OCD，强迫观念和仪式必须占用患者的大量时间（也就是说，每天总共必须持续至少一个小时）。患者每天可能会为它们花费数小时。这些强迫行为和强迫观念可能会导致极大的困苦或干扰了患者的正常行事，以至于使患者变得丧失行为能力。

大多数 OCD 患者至少能意识到他们的强迫观念与真实的风险或现实不符且他们的强迫行为是过度的。然而，少数患者深信他们的强迫观念有充分依据，且他们的强迫行为是合理的。

大部分 OCD 患者也能意识到他们的强迫行为是过度的。所以他们的强迫行为常具有隐蔽性，即便这些例行行为每天可能花费数个小时。

OCD 症状导致人际关系可能恶化，OCD 患者在学校、工作中或日常功能其他方面的表现可能下降。

许多 OCD 患者也有其他精神疾病。百分之五十一 (51)% 至 76% 的 OCD 患者被终生诊断为[焦虑障碍](#)，约 41% 的患者被终生诊断为重度抑郁症，23% 至 32% 的患者有[强迫型人格障碍](#)。

多至 50% 的 OCD 患者在某个时间点有自杀想法，约 15% 的人有实施自杀行为。如果患者还患有重度抑郁症，实施自杀行为的风险会增加（请参见[自杀行为](#)）。

强迫症的诊断

- 医生根据特定精神病诊断标准进行评估
- 体格检查，有时需要进行医学检查，以评估躯体疾病

医生基于症状来诊断强迫症：是否存在强迫观念和／或行为。强迫观念或强迫行为必须包括以下至少一项：

- 耗时
- 导致严重痛苦或干扰患者的功能

诊断还可能包括以下内容：

- 患者在多大程度上意识到其强迫想法（例如，如果他们触摸烟灰缸，他们会患上癌症）背后的信念是不准确的（“洞察力”水平）。
- 患者是否也患有或曾患有[抽动障碍](#)

强迫症的治疗

- 认知行为疗法 (CBT), 包括暴露和反应（仪式）预防
- 某些抗抑郁药物

通常首先尝试 CBT 或药物。如果患者对任一初始治疗反应不佳，可合并上述治疗。许多专家相信，暴露疗法联合反应预防治疗加药物治疗是治疗强迫症的最好方法，尤其对于较严重的症状。

CBT 在治疗强迫症方面通常很有效：暴露疗法和仪式（反应）阻止治疗是一种 [CBT](#)，通常有效。暴露疗法是指让患者逐渐反复暴露于引发强迫观念、仪式或不适的场景或人，同时要求患者不得实施强迫性仪式（仪式阻止治疗）。通过反复的暴露治疗，患者的不适或焦虑情绪逐渐消失，从而使患者明白自己的强迫行为对于减轻由强迫观念引发的不适感是不必要的。患者在接受正规治疗后，通过掌握这种方法并持续应用在日常生活中，通常可使病情改善维持数年。认知治疗技术可帮助患者识别并改变无益的思维模式，通常添加到暴露疗法和仪式预防疗法中。

某些抗抑郁药通常有效：[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 \(SSRI\)](#)（例如，氟西汀）和氯米帕明（一种同样作用于大脑化学物质血清素的旧类抗抑郁药）通常有效。SSRI 通常在氯米帕明之前尝试，因为 SSRI 的潜在副作用往往较少，可能需要比通常用于治疗抑郁症的剂量更高的剂量。对这些药物没有反应的患者，可能会向其给予其他作用机制不同的药物。

精神动力学心理治疗（注重从当前的想法、感受和行为中寻找出无意识的模式）和精神分析对强迫症患者通常无效。